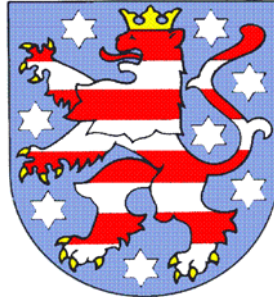


Thüringer Kultusministerium



Thüringer Lehrplan

für berufsbildende Schulen

**Schulform: Höhere Berufsfachschule
Theoretischer Unterricht**

Fachrichtungen: **Krankenpflege
Kinderkrankenpflege
Entbindungspflege
Altenpflege**

Lerngebiet: **Berufsethische Grundfragen**

Erfurt, den 05. Januar 2004

Herausgeber:

**Thüringer Kultusministerium
Werner-Seelenbinder-Straße 7, 99096 Erfurt**

Vorwort des Ministers

Thüringens Schulen werden sich noch stärker zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und selbstbewussten Einrichtungen entwickeln, die die Schülerinnen und Schüler mit den Kompetenzen für lebenslanges Lernen und erfolgreiche berufliche Tätigkeit ausstatten. Damit werden sich ihre Lehrerinnen und Lehrer, ihre Schulleitungen sowie Eltern- und Schülervvertretungen in den kommenden Jahren vielen neuen Anforderungen allgemeiner und beruflicher Bildung stellen.

Der vorliegende Thüringer Lehrplan, die landesweit durchgeführten Fort- und Weiterbildungen und ein solides Unterstützungssystem, das der ständigen Weiterentwicklung bedarf, bilden gute Voraussetzungen für erfolgreiche pädagogische Arbeit. Dabei spielen die Neuen Medien im Unterricht eine wichtige Rolle.

Eine Vielzahl von Veränderungen in der beruflichen Ausbildung haben bereits Einzug gehalten: Die schrittweise Umstellung der dualen Ausbildung durch Anwendung lernfeldstrukturierter Lehrpläne stellt in diesem Bereich hohe Anforderungen an Pädagogen und Schulleitungen. In den berufsbildenden Schulen wird fächerübergreifendes Arbeiten bei starker Handlungsorientierung immer bewusster didaktisches Prinzip der Unterrichtsgestaltung. Doppelt qualifizierende Ausbildungen und rasche technologische Entwicklungen werden zur permanenten Herausforderung für die persönliche Fortbildung aller Beteiligten.

Wir wollen und wir brauchen berufsbildende Schulen, die Mobilität, Kommunikationsfähigkeit und vielfältige berufliche Chancen auf dem deutschen und europäischen Arbeitsmarkt sichern. Im Mittelpunkt aller pädagogischen Bemühungen der beruflichen Ausbildung steht der Jugendliche, der auf die komplexen Anforderungen des beruflichen Lebens optimal vorbereitet werden soll. Die konzeptionelle Basis zur Gestaltung der Thüringer Lehrpläne allgemein bildender Schulen und die Intentionen zur Kompetenzentwicklung der KMK-Rahmenlehrpläne berufsbildender Schulen liegen folgerichtig eng beieinander.

Der vorliegende Lehrplan ist zusammen mit der Stundentafel die verbindliche Grundlage für den Unterricht, er orientiert auf die Verbindung von Wissensvermittlung und Erziehung, er zielt auf die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz mit all ihren Bestandteilen. Der Lehrplan beinhaltet bewusst auch pädagogische Freiräume, die der Lehrende eigenverantwortlich ausfüllen kann.

Allen Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung des Lehrplanes und danke allen, die bei der Erarbeitung mitgearbeitet haben und bei der künftigen Evaluierung mitwirken werden.



Dr. Michael Krapp
Thüringer Kultusminister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Vorbemerkungen	1
2 Mitarbeiter der Lehrplankommission	3
3 Didaktische Konzeption	4
4 Stundenübersicht	6
5 Lernabschnitte	7
5.1 Sinn des Lebens und berufliche Motivation und Identifikation	7
5.1.1 Fundamentalentscheidung, Lebensentscheidung, Einzelentscheidung	7
5.1.2 Die Hauptpositionen ethischer Reflexion	7
5.1.3 Ethisches Urteilen und Handeln	8
5.1.4 Das Berufsethos der Pflegeberufe	9
5.1.5 Ansatz eines allgemeinen Kriterienkatalogs zur Unterstützung beruflicher Motivation und Identifikation der Pflegekräfte	10
5.2 Grundlegende Prinzipien des Handelns in den Pflegeberufen	11
5.2.1 Das Autonomieprinzip	11
5.2.2 Das Fürsorge- und Nichtschadensprinzip	11
5.2.3 Das Gerechtigkeitsprinzip	12
5.2.4 Teamarbeit, Konfliktmanagement und Ethik	13
5.2.5 Auseinandersetzung mit grundlegenden Fragen der Helfer-Patient-Beziehung	14
5.3 Grundlegende Einstellungen des Handelnden in Pflegeberufen	16
5.3.1 Persönliche Einstellungen zu Krankheit, Schmerz usw.	16
5.3.2 Konfliktfeld: Lebensanfang	17
5.3.3 Konfliktfeld: Lebensende	19
5.3.4 Suche nach der eigenen Position im Rahmen der Konfliktbereiche Lebensanfang und Lebensende	22
5.3.5 Konfrontation der persönlichen Bewertung mit gesellschaftlicher Bewertung medizinischer Probleme	22
5.4 Vorbereitung und Gestaltung eines Projektes anhand eines Themas mit Bezug zur Ethik aus dem Themenkatalog	23
6 Literaturverzeichnis	28

1 Vorbemerkungen

Didaktisch-methodische Grundlagen

Professionelle Tätigkeit in diesen Pflegeberufen basiert u. a. auf ethisch begründeten Wertorientierungen und berufsethischen Prinzipien im Einklang mit den allgemeinen Rechtsnormen des Grundgesetzes. Fundament ist dabei Art. 1 Abs. 1 GG: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Diesem Prinzip verpflichtet, leistet das Lerngebiet einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung des Prozesses der Aneignung von entsprechenden beruflichen Kompetenzen der Schüler*, insbesondere zur weiteren Ausformung der Fähigkeit zur ethisch reflektierten fachlichen Entscheidung und zur Gewährleistung wertpluraler Hilfen vor dem Hintergrund der Achtung der Würde und der Selbstbestimmung des Einzelnen.

Den Schülern wird Gelegenheit gegeben, ihre eigene Belastbarkeit, ihre Stärken, Schwächen und Grenzen in der Begegnung mit Leid, Krankheit, Tod und Trauer herausfinden und sie für das Pflege-Patient-Verhältnis reflektiert zum Tragen zu bringen. Sie erkennen den Zusammenhang von mangelnder beruflicher Identität und gestörten Beziehungen zu Patienten und Mitarbeitern. Sie lernen es, persönliche Schuldgefühle, Opferhaltungen und Selbstüberforderungen ebenso wie unakzeptable Arbeits- und Machtverhältnisse zu hinterfragen.

Den Schülern soll die Vorstellung einer Pflegeethik vermittelt werden, die eine ganzheitliche Wertorientierung sowohl für die individuelle Betreuung der Patienten als auch für die Pflegenden selbst zur Grundlage hat. Sie werden befähigt, Konfliktsituationen im institutionellen und gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zu betrachten und sich mutig für eine Pflegeethik einzusetzen, in der sie selbstverantwortete Entscheidungsspielräume und persönliches Engagement im Beruf realisieren können, ohne die eigene Person ausklammern zu müssen. Sie werden sensibilisiert für eine Pflege, die autonomes Handeln der Pflegenden verlangt im Respekt vor der Autonomie bzw. Menschenwürde des Bedürftigen. Sie werden befähigt, Pflegepotenzen herauszufinden, die dem Patienten bzw. Heimbewohner Bedeutung geben, in einer Pflegehaltung von Distanz in der Ergriffenheit.

Das Lerngebiet trägt also wesentlich zur Sensibilisierung der Schüler für ethische Frage- und Problemstellungen im Berufsfeld, zur Reflexion eigener Werte und Normen im Hinblick sowohl die auf berufliche Tätigkeit als auch auf die individuelle Lebensgestaltung insgesamt sowie zur Befähigung zu ethischer Urteilsfähigkeit in beruflichen Entscheidungssituationen bei. Inhalte und Methoden entsprechen dem geforderten Anspruchsniveau einer eigenverantwortlich handelnden Pflegefachkraft und berücksichtigen den jeweils aktuellen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Erkenntnis- und Diskussionsstand.

Methoden

Die Anwendung des methodischen Konzeptes der Handlungsorientierung soll durch offene Organisationsformen des Unterrichts unterstützt werden und in einer Projektarbeit ihren Höhepunkt und zugleich Abschluss erfahren.

Zur Anwendung kommen sowohl Methoden, die zum Erwerb einer wissenschaftlich fundierten Ausbildung notwendig sind:

- Methoden zum Erwerb von Grundtechniken geistigen Arbeitens (Informationsbeschaffung, Anfertigung und Aufbereitung von Materialien usw.),
- Methoden zum Erwerb von ethischem Grundlagenwissen (Textarbeit, Literaturrecherche, Umgang mit kontroversen Positionen usw.),
als auch solche Methoden, die den Erwerb personaler und sozialer Fähigkeiten unterstützen:
- Methoden des selbstständigen Arbeitens (Referat, Fallbearbeitung, Präsentation von Ergebnissen usw.),
- Methoden zur Förderung sozialen Lernens (Kooperation, Gruppenarbeit, Projektarbeit),
- Methoden zur Förderung kommunikativen Handelns (freie Rede, Disputation, Diskussion, Diskurs usw.)

Die Unterrichtsgestaltung basiert vornehmlich auf vier konstitutiven Ebenen:

- wahrnehmen, erkennen, erfassen;
- analysieren, erklären;
- bewerten, urteilen, entscheiden;
- planen, handeln.

Diese vier Ebenen bedürfen der Einübung und bewussten Reflexion und sollten als durchgängiges Strukturierungsprinzip des Unterrichts genutzt werden. Dabei stehen die Vermittlung von Fachwissen und die Vermittlung von Handlungswissen nicht konkurrierend zueinander, sondern sind als sich ergänzende Einheit zu vermitteln.

* Personenbezeichnungen in laufenden Lehrplantext gelten für beide Geschlechter.

Die Projektarbeit im letzten Lernabschnitt ist entweder im Fach selbst unterrichtsbegleitend oder fächerübergreifend durchzuführen. Der Ansatz kann je nach Themenwahl sowohl als vornehmlich prozessorientiert als auch als vornehmlich produktorientiert konzipiert werden.

Umgang mit dem Lehrplan

Die Lernziele sind in ihrer jeweiligen Formulierung und Abfolge zwar verbindlich, definieren aber keinen Stoffkatalog abzuarbeitender Inhalte, sondern strukturieren den Lernprozess. Die Lerninhalte stecken den Rahmen zur inhaltlichen Unterrichtsgestaltung ab, und stellen damit ein Angebot zur Erreichung der Lernziele dar, aus dem je nach pädagogischer Ausgangssituation ausgewählt werden kann. Innerhalb des vorgegebenen Rahmens der Lernziele können sowohl inhaltliche Schwerpunkte gesetzt (im Sinne einer pädagogisch begründeten Auswahl) als auch Ergänzungen vorgenommen werden. Die didaktisch-methodischen Hinweise haben Anregungscharakter und sind nicht verbindlich. Am Ende des Lehrplanes befindet sich eine Auswahl einschlägiger Literatur als Empfehlung für die Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts.

Mit dem Lehrplan Berufsethische Grundfragen ist dem Lehrer ein Unterrichtsrahmen in die Hand gegeben, der sowohl theoretische Positionen für die Orientierung, Argumentation und Urteilsbildung der Schüler anbietet, als auch ein umfangreiches Stundenbudget für die persönliche Positionsfindung zu ethisch relevanten Fragen des Pflegealltags.

Vorrangig sucht die Arbeit mit dem Lehrplan bei allen vorgestellten theoretischen Denkansätzen die Konfrontation mit den Erfahrungen der Schüler im Berufsalltag. Sie sollen Paradoxien und Bruchstellen in ihrer Berufstätigkeit wahrnehmen und in ihrer Bedeutung für ihre Berufsmotivation verstehen lernen.

Die Erprobungsphase des Lehrplanentwurfes wird zeigen, an welchen Stellen Kürzungen und Stundenerweiterungen notwendig sind.

Der Lehrplan ist für alle Pflegefachrichtungen gleichermaßen verbindlich. Die abstrakten Themen sollten jedoch mit fachspezifischen Beispielen und Fallsituationen angereichert werden. Die Stundenverteilung gilt nur als Empfehlung und kann bei aktuellen Ereignissen und speziellen Interessen der Schüler variiert werden.

Im fachübergreifenden Projekt werden die Kenntnisse aus den Lernabschnitten 1 bis 3 an einer der Fachrichtung angepassten Thematik angewendet, vertieft und erweitert. Sie finden dazu im Lernabschnitt 4 fachrichtungsspezifische Themenvorschläge.

Die angegebenen Zeiten sind Zeitrichtwerte, in denen Zeiten für den pädagogischen Freiraum (20 %) und für Leistungskontrollen (10 %) enthalten sind.

Der pädagogische Freiraum soll vor allem genutzt werden für

- Erfahrungen und Reflexionen (schülerorientierte Didaktik)
- den Einsatz vielfältiger Methoden in der Unterrichtsgestaltung (Entwicklung der Methodenkompetenz) und
- die Förderung von Sozialformen (Entwicklung der Sozialkompetenz).

2 Mitarbeiter der Lehrplankommission

Verfasser

Marianne Gernat

Staatliche Berufsbildende Schule für
Gesundheit und Soziales
Rudolf-Breitscheid-Straße 56/58
07747 Jena

Wissenschaftliche Beratung

Prof. Dr. Nikolaus Knoepffler

Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften
Lehrstuhl für Angewandte Ethik
Zwätzengasse 12
07743 Jena

Redaktion

Dr. Axel Hermann

Thüringer Institut für Lehrerfortbildung,
Lehrplanentwicklung und Medien
Heinrich-Heine-Allee 2 – 4
99438 Bad Berka

3 Didaktische Konzeption

Mit der Implementierung der neuen Thüringer Lehrpläne in den allgemein bildenden Schulen in Thüringen wird die Schwerpunktsetzung auf die Entwicklung von Kompetenzen Veränderungen im Unterricht in Grundschule, Regelschule und Gymnasium bewirken.

Es kann daraufhin insbesondere eine verbesserte Lernkompetenz bei den Abgängern dieser Schularten erwartet werden. In der Schulart berufsbildende Schule soll nun eine konzeptionelle Basis verwendet werden, welche das Modell der genannten Schularten fortschreibt und gleichzeitig die Besonderheiten der berufsbildenden Schule einbezieht. Dabei wird die berufliche Handlungskompetenz als Weiterentwicklung der Lernkompetenz in ihrer integrativen Form angestrebt. Der Unterricht an berufsbildenden Schulen bereitet auf berufliches Handeln und auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung vor. Ziel eines solchen Unterrichts muss also die Vermittlung einer Handlungskompetenz sein, die Sach-, Selbst-, Sozialkompetenz und Methodenkompetenz enthält.

Berufliche Handlungskompetenz entfaltet sich integrativ in den Dimensionen Sach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz. Sie umfasst auch die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen Menschen, in beruflichen Anforderungssituationen sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiter zu entwickeln.

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben und Problemstellungen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht dem Schüler mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit sowie erhöhte Effizienz beim Lernen.

Kompetenzen werden in der täglichen Auseinandersetzung mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben. Sie schließen die Ebenen des Wissens, Wollens und Könnens ein. Die Kompetenzen haben Zielstatus und beschreiben den Charakter des Lernens.

Zur Gestaltung eines solchen Unterrichts mit fächerübergreifenden Ansätzen, Projektarbeit und innerer Differenzierung werden von den neuen Lehrplänen Freiräume geboten.

Dazu sollen die Lehrpläne die schulinterne Kommunikation und Kooperation zwischen den Lehrern anregen und fördern.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das sach- und handlungssystematische Strukturen miteinander verknüpft. Dies lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind an folgenden Prinzipien orientiert:

- didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die berufliche Weiterentwicklung bedeutsam sind
- den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, die vom Lernenden möglichst selbstständig geplant, ausgeführt und bewertet oder gedanklich nachvollzogen werden
- diese Handlungen sollen ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z. B. medizinische, ethische, ökonomische, ökologische, rechtliche und soziale Aspekte einbeziehen.
- bei den sozialen Aspekten sollen z. B. Interessenerklärungen und Konfliktbewältigung einbezogen werden.

Die Umsetzung des Kompetenzmodells erfordert gleichzeitig ein erweitertes Leistungsverständnis, welches mit der didaktisch-methodischen Kultur des Lernens verbunden ist und dadurch den Schülern handlungsorientiertes, entdeckendes Lernen ermöglicht.

Diese neue Herangehensweise bedingt eine neue Schwerpunktsetzung in Leistungsförderung und Leistungsbeurteilung, wobei die Gesamtpersönlichkeit des Schülers in einem mehrdimensionalen sozialen Lernprozess in den Blick genommen werden soll.

Die vom Lehrplan abgeleiteten und an den Schüler gestellten Anforderungen bilden dann die Basis der Leistungsbeurteilung. Sie umfassen in verschiedenen Niveaustufen.

- Reproduktion in unveränderter Form,
- Reorganisation als Wiedergabe von Bekanntem in verändertem Zusammenhang,
- Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Anwendungssituationen und
- Problembearbeitung.

Der Komplexitätsgrad und die Niveaustufen der vom Schüler zu bearbeitenden Aufgaben und die daraus abgeleiteten Beobachtungskriterien des Lehrers bestimmen die Schwerpunkte und Gewichtungen in der Bewertung.

4 Stundenübersicht

Lernabschnitt/Thema		Überschrift	Stunden
Lernabschnitt 5.1 Sinn des Lebens und berufliche Motivation und Identifikation			ca. 20
Thema	5.1.1	Fundamentalentscheidung, Lebensentscheidung, Einzelentscheidung	ca. 4
Thema	5.1.2	Die Hauptpositionen ethischer Reflexion	ca. 6
Thema	5.1.3	Ethisches Urteilen und Handeln	ca. 4
Thema	5.1.4	Das Berufsethos der Pflegeberufe	ca. 5
Thema	5.1.5	Ansatz eines allgemeinen Kriterienkatalogs zur Unterstützung beruflicher Motivation und Identifikation der Pflegekräfte	ca. 1
Lernabschnitt 5.2 Grundlegende Prinzipien des Handelns in den Pflegeberufen			ca. 20
Thema	5.2.1	Das Autonomieprinzip	ca. 2
Thema	5.2.2	Das Fürsorge- und Nichtschadensprinzip	ca. 3
Thema	5.2.3	Das Gerechtigkeitsprinzip	ca. 2
Thema	5.2.4	Teamarbeit, Konfliktmanagement und Ethik	ca. 5
Thema	5.2.5	Auseinandersetzung mit grundlegenden Fragen der Helfer-Patient-Beziehung	ca. 8
Lernabschnitt 5.3 Grundlegende Einstellungen des Handelnden in Pflegeberufen			ca. 30
Thema	5.3.1	Persönliche Einstellungen zu Krankheit, Schmerz usw.	ca. 3
Thema	5.3.2	Konfliktfeld: Lebensanfang	ca. 11
Thema	5.3.3	Konfliktfeld: Lebensende	ca. 11
Thema	5.3.4	Suche nach der eigenen Position im Rahmen der Konfliktbereiche Lebensanfang und Lebensende	ca. 3
Thema	5.3.5	Konfrontation der persönlichen Bewertung mit gesellschaftlicher Bewertung medizinischer Probleme	ca. 2
Lernabschnitt 5.4 Vorbereitung und Gestaltung eines Projekts anhand eines Themas mit Bezug zur Ethik aus dem Themenkatalog			ca. 10

5 Lernabschnitte

5.1 Sinn des Lebens und berufliche Motivation und Identifikation

ca. 20 Stunden

5.1.1 Fundamentalentscheidung, Lebensentscheidung, Einzelentscheidung

ca. 4 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler entwickeln ein Bewusstsein dafür, welche ihrer eigenen Werte, Ideale und Anschauungen sie zu fundamentalen Entscheidungen im Rahmen ihres persönlichen Lebenskonzeptes führen. Dabei wird ihnen einerseits deutlich, dass diese Grundhaltungen Auswirkungen auf die nachfolgenden Entscheidungsebenen haben und andererseits entsteht Klarheit über die Facetten ihrer Identität und Individualität, die sowohl ihre Berufswahl als auch ihr berufliches Handeln beeinflussen. Die Schüler sind in der Lage, den Kausalzusammenhang Motivation – Sinnsuche – berufliche Identität – Selbstentfaltung und Berufszufriedenheit auf dem Hintergrund ihrer persönlichen Sozialisation.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-metho. Hinweise
Die Schüler haben eigene Positionen zur Gestaltung eines gelungenen sinnerfüllten Lebens unter besonderer Berücksichtigung der Fundamentalentscheidung entwickelt	- die Rolle der persönlichen Identität im Rahmen der Sinnfrage <i>Wer bin ich? Wie will ich sein? Von welchen Zielen lasse ich mich leiten?</i> - Identität im Spannungsfeld von Akzeptanz und Abgrenzung gegebener Normen- und Wertgefüge - die drei Ebenen der individuellen Entscheidung in ihrem Zusammenhang: 1. FUNDAMENTALENTSCHEIDUNG (z. B. Haben oder Sein, atheistische Lebenseinstellung oder religiöse Gebundenheit) 2. LEBENSENTSCHEIDUNGEN (z. B. für Beruf, Partnerschaft) 3. EINZELENTSCHEIDUNGEN als Konkretisierung von Fundamental- und Lebensentscheidungen	- Verbindung zum Lerngebiet Psychologie - Collage als Einzelarbeit oder „Was erwartet das Leben von mir?“ (nach Viktor Frankl)
Die Schüler erkennen die Relation von Lebenssinn, Selbstbestimmung und Verantwortung	- die Aspekte des Lebenssinns (<i>Uwe Körner</i>) • Leben bewerten • Leben gestalten • Leben erleben/genießen	- eventuell Einsatz der Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow
Die Schüler begreifen die Berufsentscheidung als private Sinnfindung vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Erwartungen	- persönliche Beweggründe für die Berufswahl <i>Was will ich warum wie tun?</i> - Pflegeberuf als Berufung, Auftrag, Job, als Dienst für die Gemeinschaft - Pflegeberufe in doppelter Stellvertretung für die Kranken und die Gesellschaft im Kampf um das Leben	- Literatur <5>

5.1.2 Die Hauptpositionen ethischer Reflexion

ca. 6 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erkennen die Bedeutung und Funktion der Moral und Ethik in ihrem Bemühen um die Minimierung des Widerspruches von persönlichem Wollen und erwartetem Sollen für ein gelungenes Zusammenleben der Menschen. Die Schüler überprüfen eigene Normen, Werte und Verhaltensweisen in Bezug auf deren Eignung im Verständigungsprozess zwischen unterschiedlichen Interessenlagen ihrer Mitmenschen in Beruf und Gesellschaft. Sie verschaffen sich einen Überblick über ausgewählte philosophische Positionen in struktureller Hinsicht und durchdenken deren Erklärungen grundlegender Lebensfragen. Dabei vergleichen Sie die unterschiedlichen Aussagen unter dem Aspekt der Relevanz zu Problemkreisen in ihrem Berufsfeld.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-metho. Hinweise
Die Schüler kennen ethische Grundbegriffe	- Begriffe: Moral, Moralität, Ethik - ihre Herkunft, Bedeutung, Aufgaben - Ethik als praktische Wissenschaft in ihrer besonderen Form als Medizinethik, Bioethik und Sozialethik	- Literatur <1>
Die Schüler erwerben einen Überblick über eine Auswahl ethischer Hauptpositionen im Rahmen ethischer Reflexion in struktureller Hinsicht	- Angebote ethischer Modelle: • Tugendlehre (Aristoteles) • Hedonismus (<i>Epikur</i>) • autoritätsbestimmte Ethiken • Utilitarismus (<i>Peter Singer</i>) • Pflichtethik (<i>Immanuel Kant</i>) • Materialismus (<i>Holbach, Marx</i>) • care ethics (<i>Carol Gilligan</i>)	- Darstellung unterschiedlicher Sichtweisen und Realitätswahrnehmungen z. B. an Kippbildern - Verbindung zum Lerngebiet Psychologie - Literatur <1> Die Modellangebote sind austauschbar und ergänzbar

5.1.3 Ethisches Urteilen und Handeln

ca. 4 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sollen im Rahmen dieses Lernabschnittes die Fähigkeit erwerben, anhand ausgewählter Vorgehensalgorithmen (Schemata) Konfliktsituationen zu analysieren. Im ethischen Diskurs und Disput lernen sie ihre Positionen zu verteidigen, vernünftige Argumente zu finden, ihre Standpunkte zu korrigieren und Kompromisslösungen zu finden. Dabei wird ihnen zum einen die entscheidende Rolle von AUTONOMIE, FREIHEIT und VERANTWORTUNG für das Tun und Lassen deutlich, zum anderen aber auch die Bedeutung von Abhängigkeit und Gebundenheit in einem bestimmten Sozialsystem. In ihnen wächst zunehmend die Erkenntnis, dass ein an „guten Gründen“ orientiertes Urteilen und Handeln nicht immer auch zugleich richtig sein muss.

Die Schüler sind in der Lage, moralisch umstrittene Handlungen und Situationen über ethisches Argumentieren zu beurteilen	- sechs Klassen von Begründungsstrategien bei der ethischen Urteilsfindung (<i>A. Piper</i>) - Teilschritte einer Handlungsanalyse (<i>B. Irrgang</i>) (Situations- und Motivationsanalyse, Analyse des Handlungsentwurfes, Analyse der Mittel und Zwecke, Folgenanalyse) - zwei ausgewählte Kriterien für die Bewertung von Handlungen • Moralität: GUT und BÖSE • Pragmatismus: RICHTIG und FALSCH	- Literatur <1> - Schüler erstellen selbstständig einen Erklärungskatalog der Begriffe: Diskurs, Disput, Argumentation, ethisches Problem, ethischer Konflikt, Dilemma - Literatur <3>
Die Schüler bedienen sich ausgewählter Methoden zur ethischen Urteilsfindung unter Einbeziehung ihres eigenen Sinn- und Wertegefüges	- Modelle der Entscheidungsfindung, z. B.: • Entscheidungsfindungsmodell von V. Tschudin • die sokratische Methode (<i>Nelson, Heckmann</i>) • die Niederlagelose Konfliktlösung (<i>Rogers, Gordon</i>) • das Bochumer Inventar zur klinischen Medizinethik (BIME) • Fallanalyse nach dem Bochumer Arbeitsbogen (<i>Saas, Viefhues</i>) • fünf Schritte der Entscheidungsfindung	- Literatur <2, 6, 8> - Verbindung der Kenntnisse aus 5.1.1 bis 5.1.3 zur Beurteilung ethischer Probleme anhand von ausgewählten Konfliktfällen aus der beruflichen und/oder persönlichen Erlebniswelt der Schüler

5.1.4 Das Berufsethos der Pflegeberufe

ca. 5 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erkennen die gemeinsamen Verantwortungspflichten ihres Berufsstandes für den Patienten, für sich selbst und für die Gesellschaft im Sinne moralischer Verbindlichkeiten. Sie arbeiten Ursachen für die Diskrepanz des beruflichen Engagements der Pflegekräfte und deren Anerkennung in der Gesellschaft heraus und versuchen Wege für die Wiederherstellung der Pflegekunst als „moralische Autorität“ zu finden. Sie verstehen das Aufeinanderbezogenheit von beruflicher Motivation, beruflicher Identifikation, Selbstentfaltung und Berufszufriedenheit. Sie untersuchen, wie die praktizierte Berufsmoral Pflegenden unter dem Blickwinkel von Veränderungsmöglichkeiten, mit Perspektive einer Pflegeethik, der Stagnation, der Entfremdung von Pflegeidealen und Verhärtungen im Berufsleben vorbeugt.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-metho. Hinweise
Die Schüler verfügen über die Fähigkeit zur Unterscheidung der Begriffe BERUFSETHOS und PFLEGEETHIK	- Berufsethos als Absichtserklärung beruflich moralischen Verhaltens – als Anspruch und Verpflichtung - Beispiele berufsethischer Codizes • ICN Ethik-Codex der Pflegeberufe • Hippokratischer Eid für Mediziner - Pflegeethik – als Art und Weise der Umsetzung der berufsethischen Ideale vor dem Hintergrund von: • medizinisch-technischem Fortschritt • ökonomischem Druck und Marktmechanismen im Gesundheitswesen • der Professionalisierung der Pflege • der gewachsenen Bedeutung von Patientenautonomie	- Erfahrungsberichte der Schüler Motto: „<i>Ideal und Wirklichkeit in der Pflegerealität</i>“
Die Schüler sind für die Notwendigkeit einer kritischen Sicht der Pflegeethik sensibilisiert	- möglicher Widerspruch zwischen moralischen Prinzipien des Pflegepersonals und deren praktische Umsetzung - Konflikte und Bruchstellen in der Pflege z. B. Entwertung pflegerischen Handelns, Kränkungen der Wertvorstellungen der Pflegenden, unterschiedliche Pflegeauffassungen	- Literatur <5>
Die Schüler kennen Mechanismen der „Immunisierung“ des Pflegepersonals im paradoxal ablaufenden Pflegealltag	- Vorstellen von „Abwehr-Techniken“ des Pflegepersonals und ihrer Folgen z. B. Zynismus, Resignation, „schwarzer“ Humor - gegenwärtige Pflegementalität als ideelles Gegengewicht zu ethischen Dilemmata in der Pflegepraxis z. B. Opferkonzept, Konstrukt der Patientenzentrierung, BASISKONZEPT und FRONTKONZEPT	- Literatur <5>
Die Schüler verstehen unterschiedliche Ansätze von Pflegeethik und Medizinethik und deren Konsequenzen für die Teamarbeit	- Balance finden zwischen: • medizinischer und pflegerischer Wertorientierung • „KAMPFETHOS“ der Medizin und „AKZEPTANZETHOS“ der Pflege • ENTSCHEIDUNGSMONOPOL der Ärzteschaft und „KUSCHELETHOS“ der Pflegekräfte - Möglichkeiten zur Nutzung der unterschiedlichen Ansätze - als Basis für erfüllende Teamarbeit und Berufszufriedenheit	- Literatur <5>

Lernziele	Lerninhalte	Did.-metho. Hinweise
Die Schüler besitzen die Fähigkeit zur Reflexion von Wegen zu einer gesellschaftlich akzeptierten professionellen Pflegeethik	- Pflege in ihrem gesellschaftlichen Auftrag im Sinne einer Zuständigkeit für Pflegequalität, Existenzsicherung der Patienten und Erhaltung der Patientenautonomie - kritisches Nachdenken über: • Vereinbarkeit der Zielstellungen in der Pflege • das Kompetenz- und Machtgefälle im Klinikalltag • eine Kultur des Pflegens, des Streitens, des Umgangs mit Fehlern • unbefriedigende Halbheiten, Kompromiss- und Gewohnheitslösungen	- Literatur <5>

5.1.5 **Ansatz eines allgemeinen Kriterienkatalogs zur Unterstützung beruflicher Motivation und Identifikation der Pflegekräfte**

ca. 1 Stunde

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele:

Die Schüler verstehen, dass sich die verschiedenen Moralvorstellungen und ethischen Auffassungen nicht auf eine einheitliche ethische Theorie bringen lassen. Sie können nachvollziehen, dass es sich notwendig macht, einen guten Kompromiss zu finden, der zugleich eine Basis für handlungsleitende berufliche und private Verhaltensregeln bietet. Dies ist das Prinzip der Menschenwürde und die mit diesem Prinzip verbundenen grundlegenden medizinethischen Prinzipien

Die Schüler erfassen, dass in den medizinethischen Prinzipien das Menschenwürdeprinzip ausgestaltet wird und dadurch die verschiedenen philosophischen Ansätze mit ihren Grundwerten zu einem guten Kompromiss zusammengeführt werden	- das Prinzip der Menschenwürde Konkretisierung des Begriffes MENSCHENWÜRDE im Sinne einer prinzipiellen Anerkennung der Subjektstellung und Gleichheit aller Menschen - die grundlegenden medizinethischen Prinzipien (nach <i>Beauchamp/Childress</i>): 1. AUTONOMIEPRINZIP 2. FÜRSORGEPRINZIP (Beneficence/Paternalismus) 3. GERECHTIGKEITSPRINZIP 4. NICHTSCHADENSPRINZIP (Nonmaleficence)	- Literatur <11>
Die Schüler können überprüfen, ob sich ihre persönlichen Überzeugungen und Einstellungen zum Beruf in den medizin-ethischen Prinzipien wiederfinden	- Erarbeitung eines Verhaltenskataloges für spezifische berufsethische Kriterien • zur ethischen Orientierung des medizinischen Personals • zum Wohle des Patienten • und zur Ermöglichung einer authentischen Betreuung - Überprüfung derzeitig praktizierter Verhaltensregelungen und Leitbilder auf ihre Eignung bezüglich einer gelingenden und professionellen Helfer-Patienten-Beziehung	- Gruppenarbeit oder Einzelauftrag: <i>“Unter welchen Bedingungen möchte ich mein eigener Patient sein?”</i>

5.2 Grundlegende Prinzipien des Handelns in den Pflegeberufen ca. 20 Stunden

5.2.1 Das Autonomieprinzip

ca. 2 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler verbinden ihre theoretischen Vorkenntnisse über das Autonomieprinzip mit ihren berufspraktischen Erfahrungen. Dabei verstehen sie, dass die Achtung der Patientenautonomie zentraler Stellenwert eingeräumt werden muss, um dem möglichen Machtverlust des Kranken in der modernen Medizin entgegenzuwirken. Sie erkennen die Notwendigkeit der partnerschaftlichen Interaktion zwischen Patient und Betreuungspersonal bei der Entscheidungsfindung des Patienten für die Zustimmung zu medizinischen Maßnahmen. Die Schüler gewinnen eine Grundhaltung der Respektierung auch unverständlicher Wünsche, Ansichten und Wertekonkurrenzen.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-metho. Hinweise
Die Schüler verstehen Autonomie als ein fundamentales Charakteristikum menschlicher Existenz, das die entscheidende Grundlage für das Betreuungsverhältnis in der medizinischen Praxis darstellt	- der Vorrang des Autonomieprinzips als Abwehrrecht und Anspruchsrecht der Patienten - Informed consent – ein Instrument zur Umsetzung und Verankerung des Autonomieprinzips im klinischen Alltag und seine Orientierung am individuellen Wertesystem der Beteiligten - die Einschränkung der Einwilligungsfähigkeit und ihre Folgen für die Akzeptanz der Patientenautonomie	- Literatur <8, 9> - Gruppen oder Einzelarbeit: „Der autonome Patient im Krankenhaus – eine Utopie?“ - Literatur <10>
Die Schüler besitzen die Fähigkeit zur Wahrnehmung autonomierelevanter Konfliktbereiche im Gesundheitswesen	- Autonomie-Konflikte zwischen Selbst- und Fremdbestimmung in der klinischen Praxis (z. B. Krankenhauseinweisung, Geburtsmodus, Autonomie am Lebensende, Planung von Therapien, „Übergriffe“ von Angehörigen, Autonomie in der Psychiatrie) - die Subjektstellung des autonomen Patienten auf der Basis von Freiheit, Menschenwürde und Verantwortung trotz Institutionalisierung, Spezialisierung, Technisierung, enger rechtlicher Vorschriften und Ökonomisierung	Die Autonomiebereiche können je nach Ausbildungsrichtung ausgewählt und vertieft werden

5.2.2 Das Fürsorge- und Nichtschadensprinzip

ca. 3 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele:

Die Schüler verinnerlichen die Basistatsache, dass die Menschengemeinschaft auf gegenseitigen, fürsorglichen Austausch, Ergänzung und Unterstützung angewiesen ist. Sie erkennen die den Menschen begrenzende Rolle der Angewiesenheit und leiten daher die Notwendigkeit der Wahrung des Autonomieprinzips im Fürsorgeprinzip und Nichtschadensprinzip ab. Sie versuchen für ihr berufliches Engagement ein sinnvolles Maß an Fürsorge für den Patienten und Selbstsorge zu finden. Sie erfassen, dass sich in den konkreten Fürsorgeangeboten des medizinischen Personals nicht zwangsläufig auch die Achtung der Patientenautonomie durchsetzt, sondern, dass medizinischer Paternalismus die Mündigkeit des Patienten untergraben kann.

Die Schüler verstehen, dass die Fürsorge in gegenseitiger Verantwortung und Solidarität ein tragendes Element unserer Menschengemeinschaft ist	- das FÜRSORGEPRINZIP (Beneficence) als Sorge für andere und als Selbstsorge in seiner Verbundenheit mit dem Autonomieprinzip - FÜRSORGEERWARTUNG und FÜRSORGEVERPFLICHT als soziale Haltung in Situationen der Bedürftigkeit und Abhängigkeit	- Literatur <9> - Als Diskussionsgrundlage: 'Goldene Regel', 'Kategorischer Imperativ' möglich
--	---	---

Lernziele	Lerninhalte	Did.-metho. Hinweise
Die Schüler nehmen eine Bewertung und Folgenabschätzung der Arzt-Patienten-Beziehungsmodelle in ihren Auswirkungen auf den Patienten vor	- das FÜRSORGE- und AUTONOMIEPRINZIP im Spiegel der vier Modelle der Arzt-Patient-Beziehung: 1. PATERNALISTISCHES MODELL (Arzt als guter Vater) 2. INFORMATIVES MODELL (Arzt als Experte) 3. INTERPRETATIVES MODELL (Arzt als Berater) 4. DELIBRATIVES MODELL (Arzt als Freund und Lehrer)	- Literatur <9> Reclam Ethik in der Medizin - Diskussion: „Verstärkt der wissenschaftlich-technische Fortschritt in der Medizin die Asymmetrie der Arzt-Patienten-Beziehung?“
Die Schüler sind in der Lage, nach Kriterien für eine fürsorgliche und partnerschaftliche Helferrolle zu suchen und hinterfragen kritisch solche Berufseinstellungen wie AUFOPFERUNG und SELBSTLOSIGKEIT	- Anteilnahme, Mitgefühl und Aufmerksamkeit als Basis für Fürsorge (Care) - Hilfe, Fürsorge und Versorgung durch Ärzte und Pflegekräfte im ausgewogenen Engagement innerhalb ihrer Berufsrolle	- Bearbeitung der These: „Beziehungsorientiertheit braucht Gefühlsfunktion“ – kann ich mir das in meinem Beruf leisten? - Beziehung zu Psychologie: „Helfersyndrom“
Den Schülern wird deutlich, dass die Bemühungen im Rahmen des Nichtschadenprinzips dem Helfer-Patient-Verhältnis seine Vertrauensbasis verleihen	- die Verknüpfung des Fürsorgeprinzips mit dem Nichtschadensprinzip in der Bemühung um Schadenminimierung bei der medizinischen und pflegerischen Intervention - die Subjektivität in der Einschätzung von Schaden und Nutzen (bei medizinischem Personal und Kranken)	- Erstellen eines Schadenskataloges mit Ursachenklärung - Üben von Risikoabwägungen an Fallbeispielen

5.2.3 Das Gerechtigkeitsprinzip

ca. 2 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele:

Die Schüler erkennen die hervorragende Rolle der Gesundheit in seiner Doppelbedeutung für die Lebensplanung und Chancengleichheit des Menschen. Sie suchen gemeinsam nach moralisch akzeptablen Kriterien für eine gerechte Verteilung von Gesundheitsleistungen und werden sich dabei der Probleme und ungeklärten Maßstabs- und Umsetzungsfragen von Allokation in der Medizin bewusst. Sie schlussfolgern selbstständig welche Einflussgrößen auf gerechte Verteilungsprinzipien wirken (Wirtschaft, Politik, medizinisch-technischer Fortschritt, Demographieentwicklung usw.).

Die Schüler besitzen aktiviertes Rechts- und Gerechtigkeitsempfindens im Vergleich mit dem derzeitigen gesellschaftlichen Konsens	- Kriterien und Maßstäbe gerechter Mittelverteilung im Gesundheitswesen - Jedem das Seine? Das Gleiche für Jeden? Alles für Jeden? - Modelle der Gerechtigkeit (libertäres und egalitäres Modell) - der erweiterte Ansatz der RAWL'SCHEN CHANCENGLEICHHEIT durch <i>Norman Daniel</i>	- Literatur <11, 12, 13> - Schüler können in Gruppenarbeit unterschiedliche Gerechtigkeitsvorstellungen diskutieren
Die Schüler sind zur kritischen Betrachtung (ethischen Bewertung) der eingeschlagenen Wege in der Medizin zur Allokation auf Makro- und Mikroebene in der Lage	- die vier Ebenen der Allokation (nach <i>Engelhardt</i>) - Formen der Rationierung von Gesundheitsressourcen (z. B. Budgetierung, Umverteilung, Verweigerung, Rationalisierung/ Effektivierung, Reduzierung/ Ausdünnung, Prioritätenlisten) - RATIONIERUNG versus SPARSAMKEIT	- Literatur <12>

Lernziele	Lerninhalte	Did.-metho. Hinweise
Die Schüler verfügen über ein entwickeltes Verständnis dafür, dass Ungleichheit nur dann Gerechtigkeit ist, wenn sich daraus Vorteile für die schwächsten Glieder der Gemeinschaft ergeben	- Sollte die Gesellschaft ihre Ansprüche an die staatliche Gesundheitsversorgung ändern? - Sollte die (Gesundheits)-Politik gerechtere Anreizstrukturen schaffen? - Sollte die Medizin ihre Ziele ändern?	- Dazu könnte die Position der „3. Ära der Medizin“ von <i>Daniel Callahan</i> vorgestellt werden Literatur <12>

5.2.4 Teamarbeit, Konfliktmanagement und Ethik

ca. 5 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Den Schülern wird bewusst, dass die Art des Führungsstils, die Art des Umganges mit Teamkonflikten und die Arbeitsorganisation entscheidenden Einfluss auf die Berufszufriedenheit bzw. -unzufriedenheit haben. Sie sollen motiviert werden sich sowohl der Wahrnehmung als auch der partnerschaftlichen Lösung beruflicher Probleme und Konflikte zu stellen und in konstruktiver Weise Kompromisse zu finden. Sie verstehen zum einen die entwicklungsfördernde positive Bedeutung der Konfliktverarbeitung für das Team, dass Konflikte auch ein Produkt einer verfehlten gesellschaftlichen Rahmenordnung (Politik) sein können. Die Schüler erkennen die Auswirkungen eines vorwiegend machtorientierten Führungsstiles auf die Offenheit und Partnerschaftlichkeit im Team. Sie schlussfolgern selbstständig welche Rückwirkungen diese auf die Patientenbetreuung haben.

Die Schüler sind in der Lage, ihre eigenen Verhaltensweisen und die des Teams bezüglich ihrer ethischen Rechtfertigung zu hinterfragen	- das Team – ein Ort der Gestaltung von moralischen Überzeugungen und Idealen in der Beziehung mit Anderen z. B.: • Umgang mit neuen Erkenntnissen aus Fort- und Weiterbildung im Team • Qualität der Interaktion zwischen den Pflegekräften • kollegiale Entlastung bei Überforderung • Minimierung vorurteilsbehafteter Einschätzungen von Patienten und Mitarbeitern • kollegialer Austausch über Fragen der Verbesserung der Patientenbetreuung • Absprachen – Regelungen zwischen Ärzten und Pflegekräften - Vereinbarkeit von persönlichen moralischen Einstellungen mit Teamauffassungen	- Als Diskussionsgrundlage: <i>“Wenn Sie sich ein eigenes Team zusammenstellen könnten, wie müsste/sollte es sein ?“</i>
Die Schüler besitzen ein ethisch reflektiertes Konfliktbewusstsein und begreifen Konflikte als natürlichen und notwendigen Teil einer jeden Beziehung	- Konfliktarten und -typen aus den verschiedenen Bereichen der Berufstätigkeit (z. B. Kritik am Team, gegenseitige Grenzverletzungen, unterschiedliche Rollenerwartungen, Schuldzuweisungen im Team, arbeitsorganisatorische Probleme, Führungsstil des Managements, Zusammenarbeit von Pflegekräften und Ärzten, Belastungen in der Arbeit mit dem Patienten) - Folgen von ungelösten Konflikten als ethisches Problem in ihrer Auswirkung auf die physische und psychische Gesundheit des Personals (z. B. Mobbing, Burn-Out, psychosomatische Erkrankungen)	- vergleiche Psychologie, KGB INTERESSEN– u. WERTEKONFLIKT APPETENZ–APPETENZ–KONFLIKT APPETENZ–AVERSIONS–KONFLIKT AVERSIONS–AVERSIONS–KONFLIKT INTRA- u. INTER-ROLLENKONFLIKTE - eventuell Einladen von Pflegekräften die Erfahrung mit der Bewältigung von Teamkonflikten haben

Lernziele	Lerninhalte	Did.-metho. Hinweise
		- vergleiche Sozialmedizin - Gruppendiskussion oder Einzelarbeit: „Abfinden oder Ändern - eine moralische Entscheidung“ - vergleiche Psychologie, KGB (Altenpflege)
	- Konfliktmanagement als ethische Aufgabe in Erfüllung des Respekts vor der Menschenwürde des Einzelnen - Konfliktbearbeitung – ein integraler Bestandteil des gesamten Arbeitsprozesses (im Sinne von Teampflege) z. B.: • Balint-Gruppengespräche • partnerschaftliche Teambesprechungen • PRINZIP DER MEDIATION • SUPERVISION	- NIEDERLAGELOSE KONFLIKTLÖSUNG (Thomas Gordon, Carl Rogers) - THEMENZENTRIERTE INTERAKTION (Ruth Cohn) - VIER EBENEN EINER NACHRICHT (Friedemann Schulz von Thun)
Die Schüler haben die Akzeptanz einer maßvollen Anwendung von Macht in einem hierarchisch geordnetem System bei gleichzeitiger Teamverantwortung für die Nutzung seiner Kompetenz herangebildet	- Paternalismus versus Autonomie und deren Bedeutung für das Pflegeteam • Paternalismus versus demokratische Führung • HARTER PATERNALISMUS im Sinne der Forderung von Gehorsam und Unterordnung • WEICHER PATERNALISMUS im Sinne von Mitbestimmung autonomer Mitarbeiter bei der Gestaltung pflegerischer und organisatorischer Abläufe • Umgang mit Informationen (Bedeutung von „Herrschaftswissen“)	- mögliches Diskussionsthema: „Wer richtig führt, wird akzeptiert.“

5.2.5 Auseinandersetzung mit grundlegenden Fragen der Helfer-Patient-Beziehung ca. 8 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler begreifen, dass die Helfer-Patient-Beziehung ihre Basis in der Realisierung der Menschenwürde, Autonomiesicherung und Fürsorge besitzt. Gleichmaßen wird ihnen deutlich, dass die ständige Konfrontation mit Leid und Ausnahmesituation auch Konsequenzen für das Verhalten des Pflegepersonals haben kann, das nicht mit einer gelungenen Pflegebeziehung vereinbar ist, aber zur Natur des Menschen gehört (z. B. Aggression, Gewalt, Überidentifikation mit den Patienten, Kontaktvermeidung).

Sie erfassen sowohl die Notwendigkeit gebotener Verhaltensweisen als auch die Mechanismen, die verbotene bzw. strittige Verhaltensweisen auslösen. Die Grenzen im Pflegealltag sollten von den Schülern unter dem Aspekt der ethischen Herausforderung zu Veränderung diskutiert werden.

Die Schüler besitzen die Fähigkeit herauszufinden, welche Erwartungen die Patienten an ein ethisch fundiertes Schwester/Pfleger-Patienten-Verhältnis haben	- die Helfer-Patient-Beziehung vor dem Hintergrund der MENSCHENWÜRDE - Kriterien einer engagierten Pflegebeziehung - Anspruch und Wirklichkeit im Gefüge zunehmender Arbeitsverdichtung, komplexer werdender Arbeitsaufgaben und Funktionalisierung des Personals z. B. Gesprächsbereitschaft, partnerschaftliche Kommunikation, Akzeptanz, Echtheit, Empathie, ganzheitliche Wahrnehmung des Patienten, Stellvertreter- und Vermittlerfunktion	- Erstellung eines bedürfnisorientierten Erwartungskataloges - Erfahrungsberichte - Fallbeispiele - Checkliste für die Gestaltung eines Arbeitstages unter dem Aspekt der Verwirklichung von Autonomie und Menschenwürde - Literatur <14>
--	--	---

Lernziele	Lerninhalte	Did.-metho. Hinweise
Die Schüler verfügen über einen erweiterten Blick für die Belastungen des Pflegepersonals und die daraus resultierenden Folgen	- der gegenseitige Anspruch von Helfer und Patient auf die Wahrung der SELBSTBESTIMMUNG - die Belastbarkeit der Pflegepersönlichkeit • moralischer Druck bei der Konfrontation mit Leid, Siechtum, Schmerzen und Tod • mögliche Verhaltensfolgen, z. B.: Dezentralisierung der eigenen Persönlichkeit, moralische Selbstüberhöhung, Fluchttendenzen	- Literatur <5>
Die Schüler besitzen die Fähigkeit zum Durchdenken ausgewählter gebotener moralischer Verhaltensweisen in ihrer Auswirkung auf den Patienten (am Beispiel von Vertrauensaufbau und Verantwortung)	- Aufbau von Vertrauen • vertrauensvolle Indienstnahme des Hilfsangebotes – als Kernstück bedürfnisorientierter Pflege • Voraussetzung für Vertrauen und Auswirkungen von Vertrauen • AUTONOMIE versus VERTRAUEN ? - Verantwortung für den anvertrauten Menschen • die Mehrstelligkeit des Verantwortungsbegriffes • Verantwortungssubjekt, -bereich, -instanz, Verantwortungsarten • Konfrontation mit moralischer Verantwortung in der beruflichen Tätigkeit (z. B. Risikoabwägung, Ausloten von Entscheidungsspielräumen, Verschweigen von Fehlern, Ökonomisierung des eigenen Handelns; Zugeständnisse an die Bedürfnisbefriedigung der Patienten und ihre Folgen) • Missverhältnis von praktizierter hoher Verantwortung und geringer Entscheidungskompetenz	- Literatur <15>
Die Schüler können Ursachen für nicht zulässiges Verhalten des Personals in der Interaktion mit dem Patienten am Beispiel der Ausübung von Gewalt analysieren. Sie sind in der Lage, nach Möglichkeiten zur Prävention solcher Verhaltensweisen suchen	- Gewalt in der Pflege • Formen der Gewalt und Unterscheidung zur Aggression • Gewaltanwendung in ihrer sichtbaren und versteckten Form • Ursachen, Entstehung und Vermeidung von Gewalttaten in der Pflege ➢ Gewaltspirale ➢ Profil der Gewaltanwender ➢ Opfer-Täter-Rolle : Täter-Opfer-Rolle ➢ Gewaltdreieck (nach <i>Galtung</i>)	Literatur <16, 17>
Die Schüler sind in der Lage, Machtanwendung im Pflegeprozess als umstrittenes Verhalten zu erkennen	- die Macht in der Pflege • verborgene Macht im Pflegeregime • Formen der Macht in der Pflege: 1. DISZIPLINARMACHT 2. THERAPIEMACHT 3. ALLOKATIONSACHT 4. DEUTUNGSMACHT	Literatur <5>

Lernziele	Lerninhalte	Did.-metho. Hinweise
	• Macht versus Partnerschaft im Pflegeprozess • von der Alltagsmacht der Pflegekraft zur Bevollmächtigten für den Patienten	
Die Schüler verstehen den Zusammenhang von Paternalismus und Autonomie	- Abschlussreflexion zum Thema: Paternalismus versus Autonomie – eine ethische Herausforderung	

5.3 Grundlegende Einstellungen des Handelnden in Pflegeberufenca. 30 Stunden

5.3.1 Persönliche Einstellungen zu Krankheit, Schmerz usw.

ca. 3 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Den Schülern wird klar, dass Krankheit nicht einseitig als naturwissenschaftlicher Befund im Sinne einer Dysfunktion verstanden werden darf, sondern als ein zu interpretierender Zustand. Sie verstehen, dass die Interpretation von Krankheit auch eine ethische Aufgabe mit weitreichender Bedeutung für pflegerisches und ärztliches Handeln ist. Sie machen sich eigene Krankheits-, Leidens- und Schmerzerfahrungen bewusst und verstehen die Sinnlosigkeit der Suche nach Glaubwürdigkeitskriterien für Krankheit und Schmerz. Ihnen wird deutlich, dass sich ihre eigenen Bewertungen von Krankheit, Schmerz, usw. im Umgang mit dem Patienten widerspiegeln können, ihn aber nicht in seinem Recht auf eigene Bewertung seiner Situation einschränken darf. Sie suchen als zukünftige Pflegekräfte nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Kampf- und Akzeptanzverhalten in der Unterstützung des Patienten bei seiner Leidbewältigung.

Die Schüler besitzen ein entwickeltes Bewusstsein für die Begriffe: Schmerz, Leid, Normalität, usw. in ihrer Relativität und Abhängigkeit von der individuellen und gesellschaftlichen Interpretation

Sie erkennen die konstituierende Funktion der subjektiven Bewertung von Krankheit, Leid usw. und die sich daraus ergebende Verantwortung

Die Schüler können nachvollziehen, dass die Konfrontation mit Leid und Krankheit zu unterschiedlichen Einstellungen führen kann

- KRANKHEIT und GESUNDHEIT als von der Gesellschaft definierte Zustände und ihre komplexen Wechselbeziehungen mit biologischen, psychischen und soziokulturellen Komponenten
- Schmerz, Krankheit und Leid in ihren individuellen und kollektiven Bedeutungszuschreibungen vor dem Hintergrund der Sinnsuche in der Krise (z. B. als Strafe, Lebensprüfung vom Schicksal, „Gericht Gottes“, Warnsignal u. a.)
- LEBENSQUALITÄT und NORMALITÄT als Bewertungskriterien in ihrer Auswirkung auf die Bewertung von Leben (z. B. „lebenswertes/lebensunwertes“ Leben; Zuschreibung von Lebensrecht oder Recht auf Lebensende; Diskriminierung bestimmter Kranker und Behinderter)
- Selbstbewertung kontra Fremdbewertung von Lebensqualität und Zumutbarkeit von Belastungen
- persönliche Einstellungen des Pflegepersonals in der Begegnung mit dem leidenden Patienten, z. B.:
 - Hilflosigkeit, Schuld- und Versagensgefühl, Resignation
 - Mitleid, Überaktivität, Selbsthingabe
 - Kampfhaltung bis zum „letzten“
 - Akzeptanzhaltung, die zur Neubewertung von Zielen, anzustrebenden Werten und Rollenzuweisungen führen kann

- vergleiche Sozialmedizin: KRANKHEITSBEGRIFF, KRANKHEITSMODELLE, Paradigmenwechsel in der Medizin vom Defizitdenken zum Ressourcendenken
- Übung zur Selbstwahrnehmung der Schüler von Krankheit, Schmerz, usw.
- Diskussionsmöglichkeit zu:
 - MYTHOS: NORMALITÄT
 - NORMALITÄT auf dem Prüfstand
 - LEBENSWEERT-DEBATTE in den Zwanziger-Jahren
- Literatur <11>

Lernziele	Lerninhalte	Did.-metho. Hinweise
	• Haltung der Fürsorgepflicht • Herausforderung für das therapeutische Team zu neuen Aktivitäten und Veränderungen	
Die Schüler entwickeln Ansätze eines „ <i>Ethos der Daseinsannahme</i> “	- Balance finden zwischen „Leidverminderung um jeden Preis“ und „Bereitschaft zur Leidannahme“ - Integration von Krankheit, Leid und Schmerz in den Lebensvollzug	

5.3.2 Konfliktfeld: Lebensanfang

ca. 11 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erkennen die Notwendigkeit des Prinzips *Menschenwürde*. Ihnen wird deutlich, dass der Beginn des Menschseins und damit die Würdezuschreibung von der Interpretation des biologischen Entwicklungsstadiums abhängt, vor dem Hintergrund der jeweiligen ontologischen und moralischen Basisüberzeugung des Betrachters. Den Schülern wird sowohl der logische als auch der ethisch prinzipielle Zusammenhang der Position zur Abtreibung und zur Embryonalforschung bewusst. Wer davon ausgeht, dass dem Embryo bereits nach Abschluss des Befruchtungsgeschehens Menschenwürde und Lebensschutz zukommt, wird dies auch für das Stadium anerkennen müssen, in dem Abtreibungen vorgenommen werden. Sie finden zu einem Verständnis unterschiedlicher Positionen zum Beginn menschlichen Lebens und setzen sich mit den daraus folgenden Konsequenzen auseinander.

Die Schüler besitzen anwendungsbereites Wissen zum Begriff MENSCHENWÜRDE	- Lebensanfang im Blick auf das Prinzip der Menschenwürde • Wiederholung des Begriffes MENSCHENWÜRDE im Sinne einer prinzipiellen Anerkennung der Subjektstellung und Gleichheit aller Menschen • philosophische und theologische Begründungsversuche von Menschenwürde in ihrer Kompatibilität als Minimalkonsens • Zuschreibung und Ausschluss von Menschenwürde als Grundkonflikt am Lebensanfang, z. B.: Speziesargument, Kontinuumsargument, Identitätsargument, Potentialitätsargument, Ausschlusskriterien nach <i>Peter Singer</i>, Personalitäts- und Interessenargument • MENSCHENWÜRDE – LEBENSRECHT – LEBENSCHUTZ	- Literatur: <19> - Einsatz von Videos zu EMBRYONAL- und FETALENTWICKLUNG - Darstellung der biologischen Grundlagen der Embryonal- und Fetalentwicklung (als Hausaufgabe) - vgl. Grundgesetz
Sie kennen unterschiedliche Auffassungen zum Begriff MENSCHENWÜRDE und BEGINN MENSCHLICHEN LEBENS und finden hierzu eigene Positionen		
Den Schülern wird deutlich, dass die Entscheidung für oder gegen einen Schwangerschaftsabbruch von bestimmten moralischen Überzeugungen abhängig ist.	- Konfliktfall: SCHWANGERSCHAFTS-ABBRUCH • die Entscheidung der Frau zum Schwangerschaftsabbruch vor dem Hintergrund ihrer Position zum Status des Embryos bzw. Föten: der Embryo als Person, dem Menschenwürde zukommt oder der Embryo als bloße biologische Existenz ohne Menschenwürdeanspruch	Es können je nach Schülerinteressen andere Konfliktfelder gewählt werden: - Stammzellforschung an menschlichen Zellen des Embryoblasten - Präimplantationsdiagnostik und Pränataldiagnostik - In vitro Fertilisation - Reduktion von Mehrlingsschwangerschaften - vergleiche Gesetzeskunde (§ 218) Indikations-/Frötenlösung; Beratungspflicht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-metho. Hinweise
Die Schüler erfassen, dass sowohl die Entscheidung für als auch die Entscheidung gegen einen Schwangerschaftsabbruch mit den Prinzipien von Menschenwürde und Autonomie verbunden ist	• Abtreibung – eine Entscheidung ohne Kompromiss (medizinisch-biologische Fakten, Abtreibungsarten, Folgen, usw.) • moralische und juristische Bewertung des Schwangerschaftsabbruchs • mögliche Konfliktkonstellationen und Ambivalenzen vor und nach dem Abbruch im Spannungsfeld von Mutter – Ungeborenem – Umwelt/Gesellschaft • Anspruchsrecht, Entscheidungsmacht und Autonomie in ihren Folgen	- eventuell Bericht einer Schülerin aus dem gynäkologischen Praktikum zur Abtreibung - vergleiche: Arzneimittellehre PROSTAGLANDINE - vergleiche: Frauenheilkunde CÚRETTAGE - Fallanalysen (siehe auch Punkt 5.1.3) und Literatur <20> - Pro- und Contra-Diskussionen anhand von Fallsituationen
Die Schüler besitzen Überblickwissen zur Embryonalforschung	- Konfliktfall: EMBRYONENFORSCHUNG • embryonenerzeugende und embryonenvernichtende Verfahren in der Embryonenforschung (z. B. Gewinnung von Embryonen zu Forschungszwecken, überzählige Embryonen als Produkt der In-vitro-fertilisation, Vernichtung von Embryonen für reproduktives und therapeutisches Klonen)	- Literatur <11, 19, 21, 22> - Klärung der Begriffe: Stammzellen, adulte Stammzellen, toto- und pluripotente Zellen - Embryogenese dargestellt als Sichttafel, als Liperello, als Ausarbeitung durch Schüler selbst oder Videovorstellung
Die Schüler lernen ethische Positionen zur Embryonal-forschung kennen, die es ihnen erlauben, selbstständig über deren Zulässigkeit nach-zudenken	• Grundrecht zur Forschung versus eingeplante Inkaufnahme der Vernichtung von Embryonen • Positionen zu „verbrauchender“ Embryonenforschung 1. KATEGORISCHES VERBOT aus Zuerkennung von Menschenwürde und Schutzwürdigkeit des Embryos 2. GRADUALISTISCHE POSITION in Abhängigkeit von Entwicklungsstadien des Embryos 3. ERLAUBTHEIT aus Nichtzuerkennung von Menschenwürde für Embryonen 4. AUSNAHMEREGLUNG bei Akzeptanz der Schutzwürdigkeit des Embryos, aber in Güterabwägung von Vorindividualität der frühen Entwicklungsphase des Embryos mit hochrangigen medizinischen Zielen	- vgl: Berufs- und Gesetzeskunde: <i>Embryonenschutzgesetz</i> - Literatur <11, 19>
Die Schüler wenden ihre Kenntnisse zur Beurteilung ethischer Konflikte und Wertekonkurrenz an.	• die Frage nach der ethischen Zulässigkeit von Embryonenforschung im Blick auf: · Menschenwürde und Schutzwürdigkeit des Embryos als ranghöchstes Kriterium, Instrumentalisierung des Embryos zum Nutzen Dritter · Selbstzweckcharakter des Menschen · Bewertung der Ziele, Mittel und Risiken der Embryonalforschung	

Lernziele	Lerninhalte	Did.-metho. Hinweise
	· Umgang mit überzähligen Embryonen (Vernichtung, Verwendung, Adoption) · Vorenthalten therapeutischer Erfolge (durch therapeutisches Klonen) als Menschenwürde-Verletzung der Bedürftigen • Diskussion moralischer Einwände gegen das Klonen, z. B.: · Verstoß gegen das Gleichheitsprinzip wegen Verletzung des Rechtes auf Natürlichkeit der Abstammung · Recht auf genetisch einmalige Ausstattung des Embryos · Erwartungsdruck der Erzeuger auf den Klon nach seiner Geburt · momentane Unklarheiten über die Risiken, z. B. in der Altersentwicklung, Krankheitsanfälligkeit des Klones	

5.3.3 Konfliktfeld: Lebensende

ca. 11 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler lernen, sich den Fragen der menschlichen Endlichkeit zu stellen und eine Haltung des hilfreichen Beistandes bei der Vollendung der letzten Lebensphase zu gewinnen. Sie orientieren sich in der Vielfalt der Möglichkeiten zur Sterbehilfe unter dem Aspekt der Menschenwürde und Autonomie des Sterbenden und des Helfers. Die Schüler lernen das Altern als eine Lebensphase kennen, die wie jede andere auch ihre spezifischen Krisen, Gefährdungen und Chancen besitzt. Die alten Menschen auf diesem Weg in moralischer Verantwortung und nicht nur in legaler Pflichterfüllung zu unterstützen, begreifen die Schüler als berufliches Anliegen. Die Schüler werden sensibel für die Wahrnehmung von demütigenden und entwürdigenden Maßnahmen im Betreuungsalltag. Dabei entwickeln sie eine Motivation zur Auseinandersetzung mit unbefriedigenden Zuständen, Ausnutzung von persönlichen Entscheidungsspielräumen und Suche nach beruflichen Handlungsalternativen (trotz knapper finanzieller Mittel).

Die Schüler verknüpfen und ergänzen ihre Erkenntnisse zu Tod und Trauer und sind in der Lage, diese unter dem Menschenwürdeaspekt neu zu betrachten	- Lebensende im Blick auf das Prinzip MENSCHENWÜRDE • Sterben als ein Abschnitt im komplexen Lebensvollzug • ethische Hauptaspekte am Lebensende: - würdevolle Gestaltung des Lebensendes, Sinnerfüllung in der individuellen Biographie finden • Sterbebegleitung als moralische Fähigkeit und Aufgabe im Blick auf: Verlust, Abschied, Trauerbewältigung, Theodizee-Frage und Angehörigenarbeit • Sterbebegleitung in Hospizen (Hospizgedanke, Prinzipien, Beispiele)	- Vorstellen von Literatur und Filmen - vgl. Psychologie, Altenkrankenpflege
Den Schülern ist deutlich geworden, dass jede Sterbehilfeart unter dem Menschenwürde-Aspekt einen Konfliktfall darstellen kann bzw. darstellt.	- Konfliktfall: STERBEHILFE • Arten der Sterbehilfe unter dem Gesichtspunkt der Freiwilligkeit, mutmaßlichen Freiwilligkeit, Nichtfreiwilligkeit und Unfreiwilligkeit	- Literatur: <23, 24> Sammeln von Beispielen aus der Presse, Berufspraxis, aus Filmen, aus Gerichtsurteilen

Lernziele	Lerninhalte	Did.-metho. Hinweise
Die Schüler begreifen das Altern als Lebensaufgabe Sie verstehen, dass dieser Selbstwertungsprozess zur Sicherung von Autonomie und Menschenwürde verständnisvoll begleitet und geschützt werden muss	1. Begleitung Sterbender; Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen; Unterlassen von Maßnahmen, die den Sterbeprozess verlängern; 2. Beihilfe zur Selbsttötung 3. aktive Sterbehilfe • Argumente <i>gegen</i> jede aktive Sterbehilfe Unnötigkeitsargument; Argument des ärztlichen Ethos; Unsicherheitsargument; Vertrauensargument; Argument der „schiefen Ebene“; Missbrauchsargument, Grenzen der Selbstbestimmtheit, Tötungsverbot, Würde des Patienten versus Würde des Helfers • Argumente <i>für</i> die aktive Sterbehilfe bei Freiwilligkeit Autonomie des Patienten, Selbst- und Fremdbewertung von Lebensqualität, differenzierte Belastbarkeit im Ertragen von Leid und Schmerzen • Sterbehilfe im internationalen Vergleich (Niederlande, Australien, England, usw.) • terminale Sedierung – eine Art Sterbehilfe? • die Patientenverfügung - Anliegen und Arbeitsweisen verschiedener Sterbegesellschaften	- Vorstellen unterschiedlicher Patientenverfügungen - vgl. Gesetzeskunde und Staatskunde
	- Konfliktfall: ALTENHILFE • Altern als ein Weg zu sich selbst Biographiereflexion aus der Perspektive von Erfüllung und Misslingen, z. B.: Entwicklung von Altersweisheit, Sinnfindung, Identitätswahrung • die Bedeutung von Verlusten für Veränderungen im Alter, z.B.: · Status-, Partner-, Arbeits-, Menschenwürdeverlust, Verlust von Fähigkeiten und Gliedmaßen, Finanzen, usw. · Veränderungen wie: Arrangement mit der Endlichkeit, Entdeckung der Langsamkeit, Kraft zur Desillusionierung • Bedingungen für die Kultur eines humanen Alterns, z. B. · Rolle und Bedeutung der Altenpflegerin als „Biographiehelfer“ · Gegenseitigkeit in der Begegnung von Alt und Jung · Perspektive einer „ethischen Kehre“ oder was die Gesellschaft von den Alten lernen kann	- Literatur: <14, 25> - vgl. Psychologie: psychosoziales Entwicklungsmodell nach E. Erikson

Lernziele	Lerninhalte	Did.-metho. Hinweise
Die Schüler verfügen über ein entwickeltes Problem-bewusstsein zur Erkenntnis der ethischen Dimension im Betreuungsprozess alter Menschen	- Verhinderung des Fremdwerdens in der eigenen sozialen und kulturellen Lebenswelt alter Menschen • ausgewählte ethische Probleme in der Altenhilfe 1. institutionelle Zwänge, freiheits-entziehende Maßnahmen, Freiheit und Erhalt der Privatsphäre 2. Gewalt in der Altenpflege 3. Sexualität im Pflegeheim und sexuelle Belästigung 4. Umgang mit dementen alten Menschen 5. Umgang mit Wachkomapatienten 6. Entwicklung von Süchten 7. Sedierung von Heimbewohnern	- vgl. Gesetzeskunde
Die Schüler verstehen, dass altenpflegerische Bemühungen oft intervenierende Aktionen sind Sie entwickeln ein Gefühl für die Balance zwischen notwendiger Grenzüberschreitung und Bedürfnisrespektierung der Pflegebedürftigen	• Betreuung alter, pflegebedürftiger Menschen in Blick auf eine „Ethik der Intervention“, z.B.: · SICHERHEIT und FÜRSORGE versus AUTONOMIE und FREIHEIT (Bevormundung, Eingriffe in die Privatsphäre, Vorurteile, Förderung erlernter Hilflosigkeit) · Recht auf Entfaltung der Persönlichkeit, Schutz der Integrität alter Menschen in einer Atmosphäre der Zufriedenheit und Geborgenheit · Ermöglichung einer Privatheit und bedürfnisorientierten Lebensführung · Hilflosigkeit und Überforderung von Pflegepersonal und ihre Folgen (besonders im Umgang mit Demen-ten, Wachkomapatienten, ekelerregenden und unverständlichen Situationen)	- vgl. Artikel 2 Grundgesetz
Die Schüler verfügen über einen Einblick in die Vielfalt der Methoden der Konflikt-minimierung im Umgang mit alten Menschen zur Erweiterung der Methodenkompetenz	• Möglichkeiten zur Minimierung von Konfliktpotential als Konkretisierung des Autonomie- und Fürsorgeprinzips, z. B.: · BASALE STIMULATION · PARTNERZENTRIERTE GESPRÄCHS-FÜHRUNG und Dialogbereitschaft · INTEGRATIVE VALIDATION (nach <i>Nicole Richard</i>) · Respektierung der (sexuellen) Privatsphäre · Ausschöpfung arbeitsorganisato-rischer Möglichkeiten · Biographie- und Angehörigenarbeit · Arbeit mit Ritualen · institutionelle Sorge für Mitarbeiter (Supervision, Fort- und Weiter-bildungsmaßnahmen, Schichtrituale, Balintgruppen, usw.)	- vgl.: Psychologie Kommunikation und Gesprächsführung Krankenpflege AMÜ

5.3.4 Suche nach der eigenen Position im Rahmen der Konfliktbereiche Lebensanfang und Lebensende ca. 3 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Im Schutz der Gruppe lernen die Schüler sowohl die Berechtigung ihres eigenen Urteils als auch die Vielfalt der Standpunkte und Entscheidungen anderer zu respektieren. Dabei wächst in ihnen die Sicherheit zu ihrer eigenen Position zu stehen, weil ihnen die Bedeutung ihrer Überzeugung in Abgrenzung zu anderen Sichtweisen bewusst wird. Die Schüler verstehen, dass die Versorgung alter und sterbender Menschen ein Bekenntnis zur eigenen Endlichkeit und Unvollkommenheit voraussetzt. Die Schüler versuchen gemeinsam einen Blick für die Potenzen der unterschiedlichen Standpunkte zu entwickeln und diese in ihrer Bedeutung für das Betreuungsverhältnis zu erkennen, eventuell sogar zu nutzen.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-metho. Hinweise
Die Schüler reflektieren Übereinstimmungen und Unterscheidungen ihrer momentanen Position zu ethischen Fragen am Lebensanfang und Lebensende	- die persönliche Orientierung in der Vielfalt der angebotenen Sichtweisen zu • LEBENSBEGINN und MENSCHSEIN, PERSONSEIN • Schwangerschaftsabbruchs • Embryonenforschung - eigene Positionsfindung zu • ALTER UND ALTERN • STERBEN UND TOD • STERBEHILFE	- eventuell über Konfrontation • mit Fallsituationen • Gedichten, Liedern, Literatur • Filmausschnitten, Originaltexten/Texten
Sie sind in der Lage, schrittweise ihre Standpunkte argumentativ und kontrovers zu diskutieren und zu vertreten	- Bedeutung der eigenen Positionsfindung in ihrer Auswirkung auf den Umgang mit den Patienten und Heimbewohnern, z. B.: Akzeptanz, Flucht, Solidarität, Überstülpen eigenen Meinungen, Verletzung der Integrität der Betroffenen - Herausfinden und Akzeptieren eigener Grenzen in ihrer Bedeutung für die Pflegekraft, z. B.: Neigung zu Burn-out, Überforderung, Depersonalisierung, Demotivation, Dezentralisierung - die Pflegekraft als Verantwortliche für ihre Überzeugungen, Entscheidungen und Handlungen	- Arbeit mit der Biographiekiste aus Göttinger Projekt Frauenarbeit - Malmeditation - Abschiedsübung - Entwerfen einer eigenen Patientenverfügung <i>Zu dieser Stundeneinheit sollten nur Doppelstunden gewählt werden, da eine Aufwärmphase von grundlegender Bedeutung für die Offenheit der Schüler ist.</i>

5.3.5 Konfrontation der persönlichen Bewertung mit gesellschaftlicher Bewertung medizinischer Probleme ca. 2 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler verstehen, dass die Pflegeperson zwar ein Teil der Gesellschaft ist und somit auch am gesellschaftlichen Bewertungsprozess (z. B. Berufsethos) teilhat, aber dennoch persönliche Differenzen in der Beurteilung medizinischer Probleme haben kann. Ihnen wird deutlich, dass eine eigene ethische Problemsicht das Recht und die moralische Freiheit eines jeden ist und die Verteidigung eigener Positionen Mut, Tapferkeit und Kritikfähigkeit erfordern. Die Schüler erwerben die notwendige Sicherheit, ihren individuellen Anschauungen den Vorrang im Sinne eines Gewissensurteils zu geben. Zugleich lernen sie verstehen, dass geltendes Recht als guter Kompromiss unterschiedlicher Überzeugungen zu respektieren ist.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-metho. Hinweise
Die Schüler besitzen die Fähigkeit, konfliktrelevante Berufserfahrungen auf die drei Begründungsebenen moralischen Urteilens zu beziehen und für die Sicherung ihres eigenen Urteils zu nutzen	- individuelle Moralität im Spannungsfeld von • gesellschaftlicher Bewertung und Legalität • Vorgesetztenpaternalismus • Patienten Anforderungen - die Bedeutung von Zwang und Konformitätsdruck in konflikthafter beruflichen Entscheidungen für den Mitarbeiter - persönliche Handlungsfreiheit und moralische Freiheit und Grenzen des Gehorsams in ihren Konsequenzen - die drei Begründungsebenen moralischer Urteile als Prüfkriterium persönlicher moralischer Bewertung 1. OBERSTES MORALPRINZIP (z. B. Menschenwürde) 2. DIE MENSCHLICHE NATUR (conditio humana) • als Rahmen für die Ermittlung konkreter Normen, ausgerichtet an menschlichen Bedürfnissen • als Fundierungskriterium und Sozialkriterium mit Vorzugsregeln 3. das INDIVIDUELLE und das GESELLSCHAFTLICHE ETHOS als: • Grundlage für die Verbindlichkeit von Normen • Grundlage zur Überprüfung der Normen über Güterabwägung zur Konsensbildung - der Vorzug des individuellen vor dem gesellschaftlichen Ethos (z. B. Berufsethos)	- Aufgreifen praxisrelevanter Probleme der Schüler z. B. persönliche Einstellung zu aktiver Sterbehilfe, Ergebnisse von Bevölkerungsumfragen und rechtliche Vorgaben - Literatur: <11> - Übung an einem Schüler Schülerbeispiel s. o.

5.4 Vorbereitung und Gestaltung eines Projekts anhand eines Themas mit Bezug zur Ethik aus dem Themenkatalog ca. 10 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

In diesem Lernabschnitt laufen die bisher erworbenen Kenntnisse aus dem Ethikunterricht mit den zur Themenwahl passenden anderen Fachgebieten in einem Projekttag oder Projektunterricht zusammen. Die Schüler lernen, sich in der Vielschichtigkeit einer ethischen Fragestellung zu orientieren. Dabei wenden sie die ihnen bekannten Methoden zur ethischen Urteilsbildung und Konfliktanalyse an. Sie erproben sich in Pro- und Contra-Diskussionen und argumentativen Streitgesprächen und erweitern so ihre kommunikativen Kompetenzen. Sie lernen sowohl in der Erarbeitungsphase als auch später in der Durchführung des Projekts andere Meinungen und Standpunkte zu respektieren. Sie sind in der Lage verschiedenste Informationsquellen zum Thema zu erschließen und zu nutzen. Sie gewinnen in Zusammenarbeit mit Fachlehrern und Pflegedienstleitungen Klinikumsmitarbeiter, die sich an dem Projekttag als Gesprächspartner und/oder Vortragende zur Verfügung stellen. Sie erstellen in der Vorbereitungsphase einen Fragekatalog, der als Orientierungsgrundlage für die Zusammenarbeit mit den klinischen Fachkräften dient. Sie organisieren ihr Zeit- und Kapazitätsbudget so, dass bei aller Komplexität des Projekttag die ethischen Aspekte den Schwerpunkt einnehmen. Besondere Beachtung sollten die medizin-ethischen Prinzipien und das Menschenwürdeprinzip als Prüfkriterien für ethische Güterabwägung und ethisches Urteilen finden. Die Gestaltung des Projekttag ebenso wie die Erarbeitungsphase soll das zusammenhängende Denken der Schüler fördern und die speziellen Fähigkeiten und Fertigkeiten jedes Einzelnen zum Tragen bringen.

Vorbereitungsphase:

- Themenvorschläge aus dem Katalog prüfen
- Interessen der Schüler feststellen
- Zielsetzung
- die Arbeitsschritte für das Projekt grob festlegen
- Aufstellen einer Projektplanungsgruppe und mehrerer Arbeitsgruppen (je nach Interesse für bestimmte Arbeitsabschnitte)
- Finden eines Schülers, der die Moderation am Tag der Durchführung des Projekts übernimmt

Erarbeitungsphase/Planung:

Arbeit der Projektplanungsgruppe:

- kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Fachlehrern
- Koordination der Aktivitäten der Arbeitsgruppen, Organisation von Hilfestellungen, Metadiskussion
- Vornahme von thematischen Eingrenzungen und Schwerpunktsetzungen
- Erstellen eines Ablaufplanes für den Projekttag
- Gewinnung klinischer Fachkräfte in Zusammenarbeit mit Lehrkräften und Pflegedienstleitungen
- Auflisten möglicher Probleme am Projekttag und Abklärung im Vorfeld
- Sicherung der Mitbestimmung aller Schüler für die Gestaltung des Projekttag
- Verantwortung für die Auswertung/Retrospektive des Projekts

Arbeit der thematischen Arbeitsgruppen:

- Erarbeitung inhaltlicher Schwerpunkte und Fragenkatalog für die Spezialisten
- Exzerpieren von Fachliteratur, Internetarbeit, Erkundungen in der Praxis, Referieren von Zwischenergebnissen, Auswahl von ethischen Prüfkriterien und ethischen Entscheidungsalgorithmen innerhalb eines Themas
- Achten auf ethische Bezüge; Treffen einer Auswahl ethischer Modelle in Zusammenarbeit mit Fachlehrern; Erarbeiten einer Grundlage für den ethischen Diskurs (wo dieser möglich und sinnvoll ist)
- Erarbeitung von Arbeits- und Infoblättern für den Projekttag und wenn notwendig auch Postergestaltung
- Achten auf aktuelle Lernbezüge und gesellschaftliche Praxisrelevanz
- Koordination ihrer Arbeitsergebnisse mit Planungsgruppe, um Überschneidungen zu vermeiden

Durchführung/Präsentation

Lernziele	Lerninhalte	Did.-metho. Hinweise
Die Schüler verbinden ihre Kenntnisse aus Anatomie/ Physiologie, Krankheitslehre und Krankenpflege.	fachübergreifendes Projekt zum Thema: - ORGANTRANSPLANTATION - (am Beispiel der Niere) (a) grundlegende biomedizinische Informationen	- Vorhausaufgabe für alle Schüler: Anatomie/Physiologie der Niere - Postergestaltung, anatomisches Anschauungsmaterial
Die Schüler sollen die Belastungen des dialysepflichtigen Patienten verstehen und die Dialyse als Überbrückung zur Organtransplantation begreifen	- Indikationen zur Organtransplantation - Informationen zum Vorgang der Dialyse - Informationen zum Vorgang der Organtransplantation	- eventuell Arztvortrag - Hospitation in der Dialyse oder Vortrag durch Dialysepersonal in Zusammenarbeit mit Schülern - Arztvortrag zur Transplantation
Die Schüler beleuchten den Organwunsch und das „Recht auf ein Spenderorgan“ in seinen Folgen kritisch	(b) Herkunft der Spenderorgane – ethische Vertretbarkeit - Lebensspende aus freiem Willen oder aus moralischer Pflicht? - Entnahme der Organe von Hirntoten (in Unterstellung eines mutmaßlichen oder gesicherten Einverständnisses) - „Organtourismus“, Organhandel in seiner ethischen und juristischen Bewertung	- Darstellung der Problematik an Fallbeispielen, z. B. durch eine Psychologin oder durch Texte mit Fallbeispielen - „Organbeschaffungsmaßnahmen“ über Presseinformationen oder Dokumentarfilme vorstellen (z. B. in Indien, Mexiko, u. a.)
Den Schülern ist die Bedeutung des Hirntodes für die Praxis der Organentnahme und -transplantation bewusst	(c) der Hirntod als verlässliches Kriterium für den Individualtod - biomedizinische Fakten, Hirntodkriterien	- Schüler oder Arztvortrag - Verlaufsprotokolle der Hirntodfeststellung vorstellen

Lernziele	Lerninhalte	Did.-metho. Hinweise
	- Richtlinien zur Feststellung des Hirntodes (eventuell im internationalen Vergleich) - Darstellung der Positionen von <i>Hans Jonas, Hoff</i> und <i>Schmitt, Roth</i> und <i>Dicke</i> zum Hirntod - Probleme im Umgang mit hirntoten Patienten • Problem des Zwangs zur Irrtumslosigkeit der Ärzte bei Hirntodfeststellung • LAZARUSSYNDROM und körperliche Beschaffenheit eines reanimierten, für die Organtransplantation konditionierten Hirntoten in seiner Wirkung auf Pflegekräfte und Angehörige	- Podiumsdiskussion zum Thema: „Ist der Hirntod gleichzeitig der Individualtod?“ - eventuell Informationsblätter mit unterschiedlichen Positionen für die Schüler verteilen - Bericht von einem Intensivmediziner bzw. einer Intensivschwester, eventuell auch von einem Schüler aus dem ITS-Praktikum (Intensiv-Therapie-Station)
Die Schüler besitzen Einblick in die Faktenlage.	(d) Verteilung der Spenderorgane - Verteilungskriterien - Verteilungsinstanzen bzw. Datenbanken - Verteilungsgerechtigkeit bei bestehendem Organmangel und Kapazitätsproblemen	- Internetrecherchen - Bericht eines Transplantationsmediziners - Auswertung von Fallsituationen aus der Literatur - Beschaffung von Zahlen und Fakten aus einem regionalen Transplantationszentrum
Die Schüler reflektieren die Zumutbarkeit von Verfügungen, die nach einem eventuellen Tode moralische Entscheidungsentlastung für die Angehörigen bewirken	(e) juristische Grundlagen der Organtransplantation - enge Zustimmungslösung - erweiterte Zustimmungslösung - Widerspruchslösung - Patientenverfügung - Altersbegrenzungen für Widerspruch und Einwilligung - Bedeutung und Rechte der Angehörigen - Gesetz zur Organtransplantation (von 1997 in der jeweils geltenden Fassung)	- Zusammenarbeit mit dem Gesetzeskundeführer und dem Justitiar der Klinik
Den Schülern ist der Zusammenhang zwischen dem Vertrauen zu den Transplantationsmedizinern und der Spendebereitschaft der Bevölkerung deutlich geworden	(f) die Vertrauensfrage im Arztspenderverhältnis - Verteilungsgerechtigkeit - Möglichkeit des Dammbrech-effektes bei der Hirntodfeststellung - postoperative Versorgung des Hirntoten bzw. nach Absetzung der Konditionierung des Gesamttoten - Einhaltung der zur Spende freigegebenen Organarten und Organmengen - richtige Prognose für die Wahrscheinlichkeit des Behandlungserfolges (g) verbleibende grundlegende ethische Probleme - Verzweckung/Instrumentalisierung des Verstorbenen bzw. des Lebendspenders oder Organspende als ein Akt der Nächstenliebe ?	- Vorstellen von Fallsituationen aus dem Videoverleih/der Filmbildstelle - unter Umständen können die Inhalte aus (g) auch den Punkten (a) bis (f) zugeordnet werden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-metho. Hinweise
Die Schüler nehmen vorliegende ethische Konflikte und spezifische Wertorientierungen des Patienten wahr Sie können über eine Konfliktanalyse Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten in ihren Folgen bedenken	- Lebensschutzrecht in seinem Vorrang vor dem Anspruchsrecht auf eine „intakte“ Beerdigung (Widerspruchsregelung) oder nicht (enge Zustimmungsregelung) - Hoffnung auf eine Organtransplantation versus Vorbereitung auf den eventuell tödlichen Ausgang des Eingriffs - hoher technisch-ökonomischer Aufwand versus Therapieerfolg (h) Situation des Patienten - Vorstellen seiner medizinisch-körperlichen, psychischen, sozialen und moralischen Probleme - Konfliktanalyse, Feststellen der Wertepräferenzen und Wertekonkurrenzen des Patienten - Rolle und Bedeutung des Betreuungsteams bei der Begleitung des Transplantationsgeschehens aus der Sicht des Patienten	- Vorstellen eines Patienten, dem eine Organtransplantation bevorsteht, oder der eine solche überstanden hat - Der Patient wird entweder in seinem Beisein oder seiner Abwesenheit vom Arzt oder Psychologen vorgestellt - Die Schüler erhalten die Gelegenheit, dem Patienten selber oder dem Vorstellenden Fragen zu stellen - Danach sollte Zeit für die Informationsverarbeitung z. B. anhand des Entscheidungsfindungsmodells nach <i>Vera Tschudin</i> (oder andere) eingeplant werden
Die Schüler schlussfolgern komplex und selbstständig unter Anwendung ihres vorhandenen und durch das Projekt vertieften Wissens	(i) Ableiten berufsethischer Haltungen für die Helfer-Patient-Beziehung im Umgang mit potentiellen Organempfängern und -spendern (durch die Schüler) Bearbeitungsvorschläge, die auf vorangegangenen Unterrichtseinheiten basieren: - Fürsorge- und Nichtschadensprinzip - Autonomie- und Gerechtigkeitsprinzip - Kampfethos in Balance mit Akzeptanzethos - Care ethics/bedürfnisorientierte Pflege - Vertrauensaufbau und die Rolle der Macht im Schwester-Patient-Verhältnis - Rolle von Leid und Mitleid im Schwester-Patient-Verhältnis - Fragen der Sterbebegleitung, Abschiednehmen bei Todeserwartung - Beistand des Personals bei Abstoßung des Organs - Hilfe bei der Erstellung eines Patiententestamentes - Herausfinden eigener Grenzen und Werthaltungen - Vorstellungen über eine zufriedenstellende, erfüllende Berufstätigkeit als Pflegekraft	- Falls diese Thematik nicht im Projekt Platz findet, sollte wie in der Auswertungsphase beschrieben vorgegangen werden

Auswertung/Retrospektive

Lernziele	Lerninhalte	Did.-metho. Hinweise
Die Schüler werten das Projekt mit Blick auf berufsethische Aspekte umfassend aus und formulieren und strukturieren die Hauptergebnisse des Projektes	- Abgleich zwischen dem Ist- und Soll-Zustand des Projekts - Schlussfolgerungen für eine nächste Arbeit dieser Art als Anregung für weitere Klassen - Ableiten berufsethischer Haltungen für die Helfer-Patienten-Beziehung im Umgang mit potentiellen Organempfängern und Organspendern	- Falls dieses Thema nicht Gegenstand des Projekt-tages sein soll oder aus Zeitgründen nicht sein kann, könnte dieses Thema, mit Vororientierung der Schüler als umfassende Hausarbeit nach dem Projekttag erstellt werden. Die Arbeit dient gleichzeitig der Kontrolle des Verständnisses und als Ergebniskontrolle mit einer Note.

Projektthemen zur Auswahl für die Fachrichtungen:**KRANKENPFLEGE/KINDERKRANKENPFLEGE**

- Organtransplantation und Hirntod und ihre ethischen Bezüge
- Intensivmedizin und Ethik
- Betreuung von Wachkomapatienten aus ethischer Sicht
- Suizid als Akt der Selbstbestimmtheit in der Konfrontation mit dem ethischen Fürsorgeprinzip
- Das Früh- und Neugeborene als Patient
- Der Einzug von Hightech und Marktwirtschaft in das Gesundheitswesen, ein Anlass zur ethischen Neuorientierung?
- Normalität, Lebensqualität, Defektheilung und Behinderung in ihrer ethischen Dimension

ENTBINDUNGSPFLEGE

- Organtransplantation und Hirntod und ihre ethischen Bezüge
- Die Entbindung im Blick auf das Autonomie- und Fürsorgeprinzip
- Sterben, Tod und Abschied im Kreißsaal
- Pränatale Diagnostik und Therapie aus ethischer Sicht
- Der Kinderwunsch und seine ethischen Probleme in der Geburtshilfe
- Die Babyklappe im ethischen Blickpunkt

ALTENPFLEGE

- Organtransplantation und Hirntod und ihre ethischen Bezüge
- Betreuung von Wachkomapatienten aus ethischer Sicht
- Suizid als Akt der Selbstbestimmtheit in der Konfrontation mit dem ethischen Fürsorgeprinzip
- Normalität, Lebensqualität und Behinderung in ihrer ethischen Dimension
- Demenz und Menschenwürde – ein ethisches Dilemma?
- Der freie Wille in seiner Respektierung und Begrenzung als ethisches Problem

6 Literaturverzeichnis

VERWEIS	AUTOR	TITEL
<1>	Pieper, A.	(1991) Einführung in die Ethik UTB Franke, Tübingen
<2>	von Schayck, A.	(2000) Ethisch handeln und entscheiden Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Köln
<3>	Irrgang, B.	(1998) Praktische Ethik aus hermeneutischer Sicht UTB, Schönnigh
<4>	Wagner, H.	(1994) Ethik und Berufsverständnis der Pflegeberufe Springer, Berlin, Heidelberg, New York
<5>	Wettreck, R.	(2001) Am Bett ist alles ganz anders. LIT, Münster, Hamburg, London
<6>	Stanjek, K.	(1998) Altenpflege konkret – Sozialwissenschaften. Fischer, Lübeck, Stuttgart, Ulm, Jena
<7>	Klopfer, M.	(1994) Lerneinheit Wirtschaftsethik Nachbestellung. Siemens AG, UKD Wittelsbacher Platz 2, 80333 München
<8>	Gaul Ch	(2002) Kann Autonomie „fremdvertreten“ werden? In Ethik in der Medizin (2002)14: 160 - 169
<9>	Rehbock, Th.	(2002) Autonomie – Fürsorge – Paternalismus. Ethik in der Medizin (2002)14: 128 - 150
<10>	Dziewas, R. et aliter	(2002) Informed consent im klinischen Alltag – eine pragmatische Interpretation. Ethik in der Medizin (2002) 14: 150ff
<11>	Pöltner, G.	(2002) Grundkurs Medizinethik. Facultas UTB, Wien
<12>	Wiesing, U.	(2000) Ethik in der Medizin – ein Reader. Reclam, Stuttgart
<13>	Fän, H. et aliter	(1987) Ethik Arbeitsbuch Klasse 12 Gymnasium. Konkordia, Bühl
<14>	Blonski, H.	(1998) Ethik in der Gerontologie und Altenpflege. Brigitte Kunz, Hagen
<15>	Sänger, M.	(1991) Arbeitsbuch für den Unterricht Verantwortung. Reclam, Stuttgart
<16>	Entzian, H. et aliter	(2000) Gleich nehme ich ihr die Klingel weg Übergriffe, Vernachlässigung und Misshandlung – Gewalt in der Pflege. Kiel, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Schleswig-Holstein
<17>	Huber, A.	(1995) Aggression und Gewalt. Hayne, München
<18>	Korff, W. et aliter	(2000) Lexikon der Bioethik CD-ROM (Best-Nr. 3-579-02672-0). Güthersloher Verlagshaus, Güthersloh
<19>	Knoepffler, N.	(2004) Menschenwürde in der Bioethik (Springer)
<20>	Staup, G.	(1996) Unter anderen Umständen . (eine Publikation des Deutschen Hygiene Museums, Dresden) edition ebersbach, Dortmund
<21>	Maier, B.	(2000) Ethik in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Springer, Berlin, Heidelberg, New York
<22>		Gene · Klonen · Fortpflanzung. Spektrum der Wissenschaft, 72 - 77, 46 - 47, 38 - 44
<23>	Quante, M.	(1998) Passive, indirekte und direkte aktive Sterbehilfe – deskriptiv und ethisch tragfähige Unterscheidungen. Ethik in der Medizin (1998) 10: 296 - 226
<24>	Gutmann, Th.	(2002) Der eigene Tod – die Selbstbestimmung des Patienten und der Schutz des Lebens in ethischer und rechtlicher Dimension Ethik in der Medizin (2002) 14: 170 - 185

VERWEIS	AUTOR	TITEL
<25>	Cook, B.	(1995) Verlust und Trauer Bedeutung – Umgang – Bewältigung. Ullstein Mosby, Berlin, Wiesbaden
<25>	Anschütz, F.	(1996) Suizidprävention und Sterbehilfe Ullstein Mosby, Berlin, Wiesbaden
<27>	Saas, H.-M.	(1989) Medizin und Ethik. Reclam, Stuttgart